ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

悪い知らせの伝え方（SPIKES）

患者と家族に深刻な知らせを伝える ― SPIKESの6段階、NURSEで感情に応え、ICUの家族面談と難しい場面へ広げる

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-31

悪い知らせ（bad news）は、相手の将来の見通しを大きく、悪い方向へ変える情報すべてを指します [Baile Oncologist2000]。がんの告知に限りません。ICUでは、急変の説明、治療が効いていないことの説明、生命維持治療の差し控え・終了の相談、死亡や脳死の告知がこれに当たり、聞き手の多くは患者本人ではなく家族です。SPIKESは、こうした面談を6つの段階に分けて準備し、実行し、振り返るための手順です [Baile Oncologist2000]。

治療の目標の決め方と、生命維持治療の差し控え・終了の手続きはICUの臨床倫理と終末期の意思決定で扱います。この資料は、その話し合いで「どう話すか」を扱います。

§1 悪い知らせと、手順が要る理由

知らせの重さは、中身だけでは決まりません。受け手が何を予期していたかとの差で決まります。同じ「意識が戻る見込みは低い」という説明でも、回復に向かっていると思っていた家族と、覚悟していた家族とでは受け止め方がまったく違います。SPIKESが伝える前に相手の認識を聞く段階を置くのは、このためです [Baile Oncologist2000]。

1-1. 伝える側に起きること

悪い知らせを伝える側も、不安・責任感・相手の否定的な反応への恐れから強いストレスを感じ、伝えるのを避けたり、手短に済ませたりしがちです。相手がすでに動揺していると、この傾向は強まります（MUM効果） [Baile Oncologist2000]。

1998年の米国臨床腫瘍学会のシンポジウム参加者への調査では、悪い知らせの伝え方の正式な教育を受けた人は4.8%、伝えるときに一貫した方法を持つ人は26.1%でした。最も難しいこととして58.0%が「正直に伝えつつ希望を奪わないこと」を挙げ、SPIKESの中で最も難しい段階には52.4%が感情への対応（E）を挙げました [Baile Oncologist2000]。多くの医師は、先輩の面談に同席して見よう見まねで覚えています。手順にすると、教えられ、練習でき、振り返れる技能になります。

1-2. 聞く側に起きること

急性ストレスの研究から組み立てた概念モデルでは、深刻な知らせは、言葉の意味が理解される前に脳の扁桃体と島皮質で「危険」として受け止められ、続いて出るカテコラミンとコルチゾールが注意の幅を狭め、作業記憶と複雑な内容の記銘を妨げると考えられています（図1） [Rusinova ICM2026]。

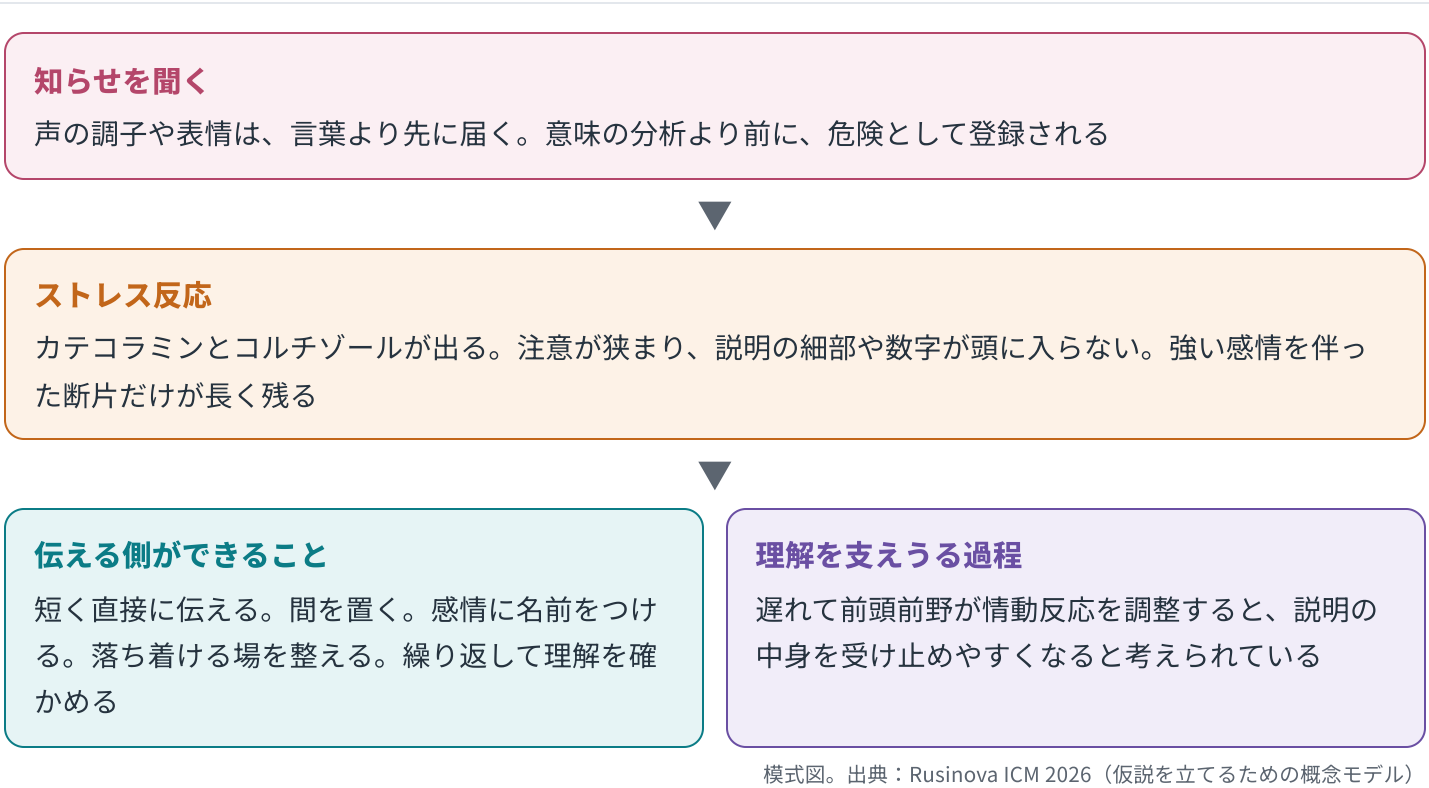


図1. **悪い知らせを聞いたときに理解が止まる仕組み**

> 混乱・沈黙・怒り・無反応は、理解力が足りないのではなく、生理的に負荷がかかりすぎているサインと読みます [Rusinova ICM2026]。この総説は実験室の急性ストレス研究から組み立てたモデルで、悪い知らせの場面そのものを測った研究ではありません。それでも、間を置く・小分けにする・繰り返して確かめるといった従来の推奨とよく合います。

ICUの家族の理解は、思っているより届いていません。フランスのICUで家族の代表に面接した研究では、医師との初回面談は平均10分で、54%が診断・予後・治療のいずれかを理解できていませんでした。医師の側で理解不足に関わったのは、初回面談が10分未満であることと、説明用のパンフレットを渡さないことでした [Azoulay CCM2000]。

1-3. SPIKESの全体像

SPIKESは、Setting up（準備と場の設定）、Perception（認識を聞く）、Invitation（知りたい範囲を聞く）、Knowledge（伝える）、Emotions with empathy（感情に応える）、Strategy and summary（方針と要約）の頭文字です（図2） [Baile Oncologist2000]。PとIは「伝える前に聞く」段階、Eは感情に応える段階です。

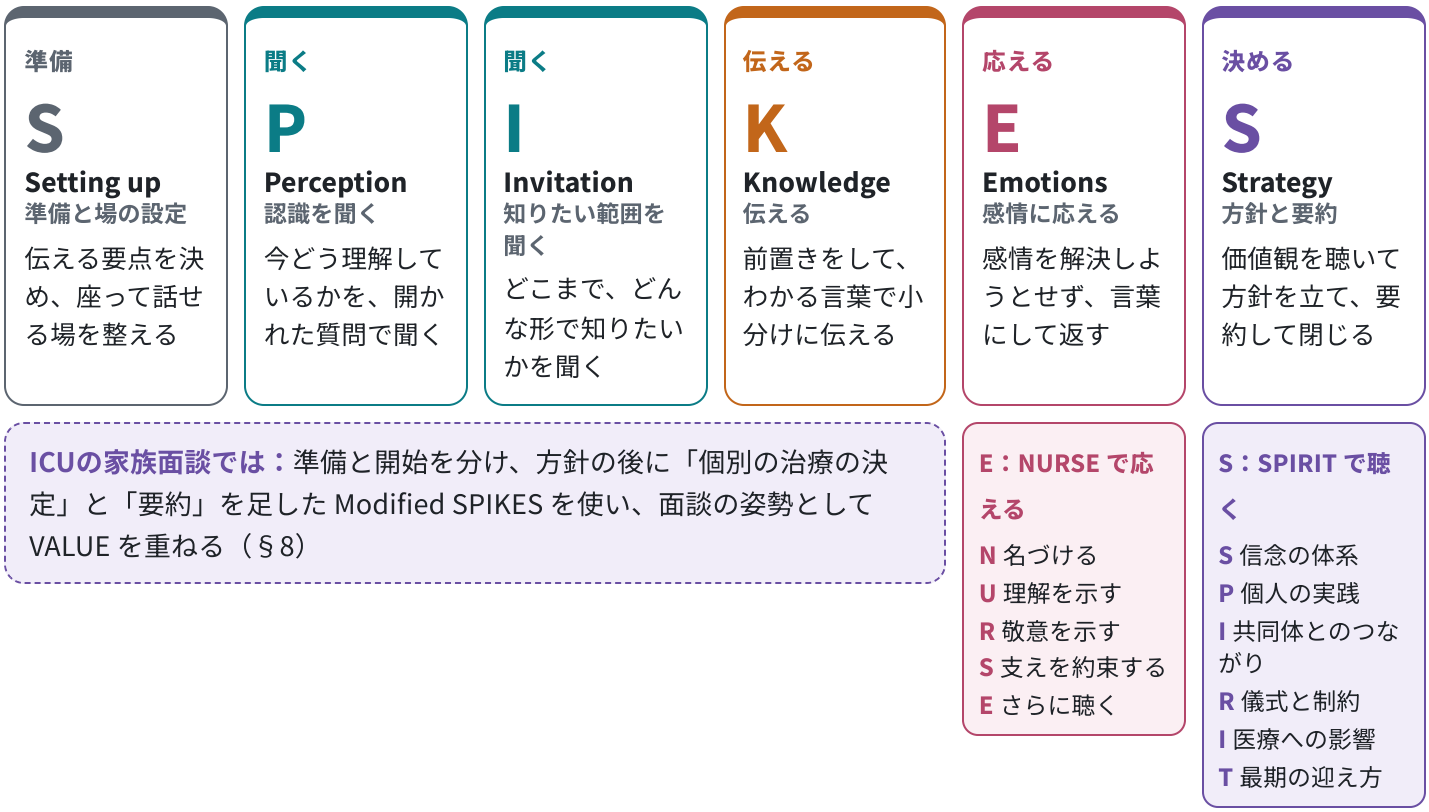


図2. **SPIKESの6段階と、NURSE・SPIRITの位置**

面談の目標は4つです。相手の理解と期待を知る、相手の希望に合わせてわかる情報を渡す、感情に応えて支える、今後の方針を一緒に立てる、です [Baile Oncologist2000]。6つの段階は一方通行の手順ではなく、面談の中で行き来します。Kの途中で感情があふれたらEに戻り、落ち着いてからKを続けます。

1-4. 日本の患者が望むこと ― SHARE

SPIKESは米国のがん診療から生まれました。日本では、がん患者自身の希望を調べた研究から、SHAREという枠組みが作られています [Fujimori Psychooncology2007] [Fujimori JCO2014]。

日本のがん外来患者529人の調査では、90%超が「今の病状と治療の選択肢を医師と話し合うこと」と「医師が家族の気持ちにも配慮すること」を強く望みました。一方、余命の情報を望んだのは半数で、30%は望みませんでした。希望は4つの因子にまとまりました（表1） [Fujimori Psychooncology2007]。

表1｜SHAREの4要素とSPIKESの段階

SHAREの要素	中身	SPIKESの段階
Supportive environment（支持的な場）	落ち着いて話せる場、十分な時間、家族の同席	S（準備）

SHAREの要素	中身	SPIKESの段階
How to deliver（伝え方）	正直に、わかりやすく、相手のペースで伝える	P・I・K
Additional information（付加的な情報）	今後の治療、日常生活への影響、ほかの意見を聞く機会	S（方針）
Reassurance and Emotional support（安心と情緒的な支え）	気持ちへの配慮、家族への配慮、見捨てないと伝える	E

余命を知りたいかどうかは人によって分かれ、その違いは教育歴やがんへの心理的な適応と関連しました [Fujimori Psychooncology2007]。どこまで知りたいかを決めつけずに聞く段階（I）は、日本でも省けません。

§2 準備と場の設定（S：Setting up）

Setting up は、面談の前に伝える内容と段取りを決め、落ち着いて話せる場を整える段階です。何をどう言うかを頭の中で一度通しておくと、面談の途中で迷いません [Baile Oncologist2000]。

2-1. 面談の前にチームで決めること

ICUの面談は医師1人では行いません。関係する職種と家族を1つの部屋に集め、進行役を1人決め、面談の目標をチームで先にそろえます（表2） [Cerceo FamilyMeeting]。

表2｜面談の前にチームで決めること

決めること	中身
医学的な事実	カルテで経過・検査・治療を確かめる。主治医・関連科の見立てが食い違っていないか確かめる [Cerceo FamilyMeeting]
いちばん伝えたいこと	今日の面談で必ず伝える要点を1〜2文にする。病状と治療、予後（生存・回復・生活の質）の2点に絞る [Cerceo FamilyMeeting]
チームの推奨	方針の提案があるなら、その内容と理由をそろえておく
誰が話すか	進行役を1人決める。看護師・ソーシャルワーカー・緩和ケアなど、同席する職種と役割を決める [Cerceo FamilyMeeting]
誰に来てもらうか	意思決定に関わる家族。人数が多いときは、本人や家族に代表を選んでもらう [Baile Oncologist2000]

面談の前にチームの見解をそろえておくことは、家族との対立を予防する手段でもあります。チームの中で言うことが違うと、家族は「誰が決めているのか」に不信を持ち、対立がこじれやすくなります（§9-1） [Jabaley CritCare2026]。

2-2. 場を整える

プライバシーが守られず、落ち着いて話せない場所では、面談の目標は果たせません [Baile Oncologist2000]。

- 面談室を使う。使えなければベッドのカーテンを閉める。ティッシュを用意する [Baile Oncologist2000]
- 座る。座ると相手が落ち着き、急いでいないことが伝わる。相手との間に机などの障害物を置かない [Baile Oncologist2000]
- 視線を合わせる。相手が受け入れるなら、腕や手に触れることも関係をつくる方法になる [Baile Oncologist2000]
- 時間の制約と、入りそうな中断を先に伝える。PHSは消音にするか、ほかの医師に預ける [Baile Oncologist2000]

2-3. 面談を始める

ICUの面談では、場の準備と面談の開始を分けて考えます。出席者を全員紹介し、面談の目的と時間の枠を先に示します [Cerceo FamilyMeeting]。

紹介

「集中治療科の医師の〇〇です。こちらは担当看護師の〇〇、ソーシャルワーカーの〇〇です。皆さまのお名前と、ご本人とのご関係を教えていただけますか」

目的

「皆さまにとって大変なときだと思います。今日は、今の状態をご説明して、ご質問にお答えしたいと思います」

時間の枠

「今日は30分ほどお時間をいただいています。足りなければ、また改めて時間をつくります」

中断の予告

「途中で病棟から呼ばれることがあります。そのときは一度席を外しますが、必ず戻ります」

家族との最初の面談は、ICU入室から72時間以内が目安として引用されています [Hwang CCM2025]。悪い知らせが出てから慌てて初対面の面談をするより、早めに顔を合わせておく方が、その後の面談が進みます。

§ 3 認識を聞く（P：Perception）

Perception は、知らせを伝える前に、相手が今の状態をどう理解しているかを開かれた質問で確かめる段階です。原則は「伝える前に聞く（before you tell, ask）」です [Baile Oncologist2000]。

3-1. 開かれた質問で始める

相手の理解を知ると、誤解を正し、知らせをその理解に合わせて伝えられます。同時に、否認のサイン（願望に沿った解釈、不利な事実の省略、治療への非現実的な期待）があるかもわかります [Baile Oncologist2000]。

理解を聞く

「これまで、今の状態についてどのように説明を聞いていらっしゃいますか」

認識をそろえる

「まず、皆さまが今の状態をどう受け止めていらっしゃるか、確かめさせてください」

家族の目で見た経過

「この数日、ご家族から見て、ご本人の様子はどうでしたか」

気がかり

「今いちばん気がかりなことは何ですか」

聞いた答えを、医学的な正しさで採点しないことが大切です。「肺炎は治ってきていると聞いています」という答えから、前の説明のどこが残り、どこが伝わっていないかがわかります。

3-2. 家族が話す時間をつくる

家族が話す時間が長い面談ほど、家族の満足度は高くなります [McDonagh CCM2004]。

終末期の判断を扱うICUの家族面談51回を録音した研究では、面談の長さは平均32分で、家族が話したのは29%、医療者が話したのは71%でした。家族の発話の割合が大きいほど、医師のコミュニケーションへの満足度が高く、医師との対立の評価が低くなりました。面談の長さそのものと満足度は関連しませんでした [McDonagh CCM2004]。医師は、説明が長くなり技術的な話に偏りがちなことを自覚しておきます [Cerceo FamilyMeeting]。

3-3. 予後の受け止めのずれ

家族と医師の予後の見立ては、半分ほどの組み合わせでずれています。そのずれは、説明の誤解だけでなく、家族の信念からも生まれます [White JAMA2016]。

死亡リスクの高い患者174例で、医師と代理意思決定者（家族）229人の予後の見積もりを比べた研究では、20%以上のずれが229件中122件（53%）にありました。ずれの原因を229件全体に対する割合で見ると、医師の見立ての誤解と信念の違いの両方が28%、誤解だけが17%、信念の違いだけが3%で、12件は原因のデータが欠けていました。家族が医師より楽観的だった理由には、希望を保つことが患者のためになるという考えや、宗教的な信念が挙がりました [White JAMA2016]。

このため、「医師から何を聞いたか」と「ご家族としてどうなると思っているか」を分けて聞きます。前者のずれは説明で埋まりますが、後者のずれは説明を繰り返しても埋まりません。後者には§6の感情への応答と、§9-2の願いへの応答で向き合います。

聞いた内容

「医師からは、今後の見通しについてどのように聞いていらっしゃいますか」

家族の見立て

「説明とは別に、ご家族としては、これからどうなっていくと感じていらっしゃいますか」

§4 知りたい範囲を聞く（I：Invitation）

Invitation は、相手がどこまで詳しく、どんな形で知りたいかを確かめる段階です。多くの人は診断・予後・病状の詳しい情報を望みますが、望まない人もいます。情報を避けることも正当な心理的な対処の1つで、病気が重くなるほど出やすくなります [Baile Oncologist2000]。

4-1. 許可を取ってから伝える

相手が知りたいとはっきり言ってから伝えると、伝える側の不安も軽くなります [Baile Oncologist2000]。**基本の型は、聞く → 伝える → 聞く（ask-tell-ask）です** [Back CACancerJClin2005]。

情報の量

「検査の結果について、すべて詳しくお話しした方がよいですか。それとも要点をお伝えして、これからの治療のお話に時間を使いましょうか」

見通しの許可

「これから先の見通しについて、私たちの考えをお話ししてもよろしいですか」

数字の希望

「見通しを数字で知りたい方と、数字は聞きたくない方がいらっしゃいます。どちらがよろしいですか」

聞く人の希望

「大事なお話を、どなたと一緒に聞きたいですか」

知りたい範囲は、検査を出す時点で聞いておくと、結果が出たときの面談を組み立てやすくなります [Baile Oncologist2000]。知りたい範囲は家族の関わりで変わることもあります。日本語の解説書は、家族に後押しされて初めて「詳しく聞きたい」と言えた患者の例を示しています [渡辺 SPIKES解説]。

4-2. 知りたくないと言われたら

詳しく知りたくないと言われたら、無理に伝えず、知りたくなったらいつでも答えると伝えます。代わりに説明を聞く家族や友人がいるかを確かめます [Baile Oncologist2000]。

ICUでは、患者本人が話せず、家族が代理で判断する場面がほとんどです。家族の中で知りたい範囲が分かれるときは、詳しく聞きたい人と別に時間をとる、知りたくない人には席を外してよいと伝える、などで調整します。代理で判断する役割を担う人に、判断に必要な情報が届かない形にはしません。

§5 伝える（K：Knowledge）

Knowledge は、医学的な事実を、相手の理解の水準と語彙に合わせて伝える段階です。面談の中で医師から家族への一方向の部分なので、いくつかの決まりを守るだけで伝わり方が変わります [Baile Oncologist2000]。

5-1. 前置きをして、要点を一文で

悪い知らせが来ると先に予告すると、衝撃が和らぎ、その後の情報が入りやすくなる可能性があります [Baile Oncologist2000]。**予告の後は、要点を単純に、直接に伝え、すぐに間を置きます** [Rusinova ICM2026]。

前置き

「残念ながら、よくないお知らせをしなければなりません」

要点（一文）

「脳の出血はとても大きく、意識が戻る見込みは非常に低いと考えています」

間

「（言い終えたら、説明を続けずに待つ。相手が口を開くまで、こちらから話さない）」

理解の確認

「今お話ししたことについて、どんなことでもお聞きください」

要点を言った後に沈黙が続いても、急いで説明で埋めません。§1-2のとおり、聞いた直後の家族には細かい説明が入りません。説明の続きは、家族が話し始めてからにします。

5-2. わかる言葉で、小分けに

相手の理解と語彙の水準から始め、専門用語を避け、情報を小分けにして、その都度理解を確かめます。突き放すような率直すぎる言い方は避けます [Baile Oncologist2000]。

表3｜ICUでよく使う言葉の言い換えの例

専門用語	言い換えの例
挿管・人工呼吸	口から気管に管を入れて、機械で呼吸を助けています
昇圧薬	血圧を支えるための点滴の薬です。量が増えているのは、体が自分で血圧を保てなくなっているということです
多臓器不全	肺・心臓・腎臓など、いくつもの臓器が同時に弱っています
敗血症性ショック	感染症をきっかけに全身の血のめぐりが悪くなり、臓器が弱っている状態です
予後不良	命が助からない可能性が高いと考えています
心肺蘇生をしない（DNAR）	心臓が止まったときに、心臓マッサージや電気ショックは行いません。それ以外の治療や苦痛を和らげる治療は続けます

原著は「転移した」を「広がった」、「生検」を「組織を少し取って調べる」と言い換える例を挙げています [Baile Oncologist2000]。図や実物を使うこと、処置に関わる看護師から説明してもらうことも助けになります [渡辺 SPIKES解説]。

5-3. 予後と不確かさを伝える

伝える中身は、病状と治療、そして予後（生存・回復・生活の質の見通し）の2点です。予後が不確かなら、不確かであることを正直に伝えます [Cerceo FamilyMeeting]。

不確かさを伝えるときの型が「最善を望み、最悪に備える（hope for the best, prepare for the worst）」です。希望と心配を対立させず、並べて話します [Back AnnInternMed2003]。外科で作られた Best Case/Worst Case は、最善の経過・最悪の経過・最もありそうな経過を具体的に描いて示す道具です [Kruser JPainSymptomManage2017]。

不確かさ

「この先どうなるか、はっきりお伝えできればよいのですが、正直なところ、まだわかりません」

希望と備え

「私たちも、よくなることを願って治療を続けます。同時に、よくならなかったときのことも、一緒に考えておきたいと思います」

最もありそうな経過

「いちばんよい場合は〇〇、いちばん悪い場合は〇〇です。私たちがいちばんありそうだと考えているのは〇〇です」

質問を促す

「たくさんのことをお話ししました。わからなかったことや、気になったことはありますか」

5-4. 使わない言葉

予後が悪いときでも「もうできることはありません」とは言いません。痛みを取る、症状を和らげるといった、患者にとって大切な治療の目標は残っているからです [Baile Oncologist2000]。**「ケア」や「治療」をやめる、という言い方も使いません** [Cerceo FamilyMeeting]。

表4｜避けたい言い方と言い換え

避けたい言い方	家族への伝わり方	言い換えの例
「もうできることはありません」	見放された	「病気そのものを治す手段は残っていませんが、苦しくないように過ごしていただくためにできることは、たくさんあります」
「治療をやめます」	何もしてもらえなくなる	「効果の見込めない治療は控え、苦痛を和らげる治療に力を注ぎます」
「がんが転移していて、すぐに治療しないと亡くなります」	突き放された・責められた	前置きをしてから、要点を一文で伝え、間を置く（§5-1）

避けたい言い方	家族への伝わり方	言い換えの例
「どうしますか」（選択肢だけを並べる）	家族だけで決めさせられる	価値観を聴いたうえで、医師から推奨を示す（§7-3）

突き放すような率直すぎる言い方は、相手を孤立させ、後で怒りを生み、知らせを伝えた人を責める方向に向かいやすくなります [Baile Oncologist2000]。

§6 感情に応える（E：Emotions with empathy）

共感的な応答（empathic response）は、相手の感情に気づき、その感情と理由を言葉にして返すことで、相手が1人ではないと伝える応答です。悪い知らせへの反応は、沈黙・信じられない思い・涙・否認・怒りとさまざまで、その多くは衝撃・孤立・悲嘆の表れです。感情が落ち着かないうちは、次の話には進めません [Baile Oncologist2000]。

6-1. 共感の4つの動作

原著は共感的な応答を4つの動作に分けています（図3） [Baile Oncologist2000]。

① 観察する
涙ぐむ、悲しそうな表情、沈黙、呆然とした様子など、感情のサインを見つける

▼

② 名づける
その感情が何か（悲しみ・怒り・恐れなど）を、自分の中で名づける。わからなければ開かれた質問で尋ねる

▼

③ 理由を確かめる
多くは悪い知らせが理由。確信が持てなければ、相手に尋ねる

▼

④ つなぐ言葉
少し時間をとって気持ちを出してもらった後、感情とその理由を結びつけて言葉にする

感情が収まらなければ、落ち着くまで共感的な応答を続けます。

出典：Baile Oncologist 2000

図3. **共感的な応答の4つの動作**

> たとえば、医師が「残念ながら、治療が効いていないことがわかりました」と伝え、家族が「やっぱり……」と泣き出したとします。医師は少し椅子を近づけ、ティッシュを渡して間を置き、「お聞きになりたくない知らせだったと思います。私も、もっとよい結果をお伝えしたかったです」と返します。涙を観察し、悪い知らせが理由だと判断し、感情と理由をつなぐ言葉にしています [Baile Oncologist2000]。感情がはっきり表に出ていないとき（沈黙など）は、共感の言葉の前に、探る質問をします。

6-2. 感情に説明で答えない

感情があふれているときに医学的な説明を重ねても、§1-2のとおり頭に入りません。感情を「解決」しようとせず、まず言葉にして返します [Cerceo FamilyMeeting] [Rusinova ICM2026]。

よくある落とし穴は、相手の感情を遮る（話題を変える）、講義をする、決まった手順に頼る、早すぎる安心づけをする、です [Back CACancerJClin2005]。「なぜこんなことに」「もっと早く気づいていれば」という言葉は、多くの場合、質問ではなく感情の表れです。ここで経過を説明し直すより、「ずっと気にかけていらしたのですね」と返す方が届きます。

6-3. NURSE

NURSEは、感情への応答を5つの型にまとめた覚え方です（表5） [Back CACancerJClin2005] [Cerceo FamilyMeeting]。どの型も、感情を言葉にして受け止めることが目的で、問題を解決することではありません。

表5｜NURSE：感情に応える5つの型

型	すること	言い回しの例
Name（名づける）	見えている感情を言葉にする	「とても動揺していらっしゃるように見えます」
Understand（理解を示す）	相手の置かれた状況の重さを受け止めていると伝える	「これは本当につらい状況だと思います」
Respect（敬意を示す）	家族の努力や姿勢を認める	「お父様のお考えを大事にしようとされているのが、よく伝わります」
Support（支えを約束する）	これからも一緒にいると伝える	「これからも一緒に考えていきます。明日またお話ししましょう」
Explore（さらに聴く）	気持ちや考えをもう少し話してもらう	「今どんなことを考えていらっしゃるか、もう少し聞かせていただけますか」

N：怒り
「こんなことになって、納得がいかないお気持ちなのだと思います」

N：心配
「ご心配なことが、たくさんおありなのですね」

U：代理の判断
「ご本人に代わって決めるのは、とても重いことだと思います」

R：付き添い
「毎日来てくださって、ご本人のそばにいてくださっていますね」

R：質問
「大切なことを、たくさん質問してくださっています」

S：見捨てない
「どういう方針になっても、私たちが最後までご本人とご家族を支えます」

E：気がかり
「いちばん気がかりなのは、どんなことですか」

E：言葉の意味
「「かわいそう」とおっしゃったのは、どういうお気持ちからですか」

6-4. 共感・探索・承認の3つの言葉

原著は、感情に応える言葉を、共感の言葉、探る質問、承認の言葉の3つに分けています（表6）。3つを組み合わせることが、相手を支える最も強い方法の1つです [Baile Oncologist2000]。

表6｜共感・探索・承認の言葉の例

種類	働き	言い回しの例
共感の言葉	相手の感情を受け止めて返す。医師自身の気持ちを添えてもよい	「思ってもいなかったお知らせだったと思います」／「私も、もっとよい結果を期待していました」
探る質問	感情がはっきりしないとき、何を感じているかを尋ねる	「それは、どういうことでしょうか」／「何がいちばん心配か、教えていただけますか」
承認の言葉	その感情や考えが自然で、もっともだと伝える	「そう感じられるのは当然だと思います」／「同じように感じられるご家族は、たくさんいらっしゃいます」

ICUの家族面談51回の録音では、共感の言葉が1回以上あった面談は66%で、面談1回あたり平均1.6回でした。共感の内容は、重い病気の家族を持つつらさ（31%の面談）、代わりに決めるつらさ（43%）、死と向き合うつらさ（27%）の3つでした。家族がはっきり感情を表したことへの応答だったのは、共感の言葉の30%だけでした。共感の言葉が多い面談ほど、家族の満足度は高くなりました [Selph JGIM2008]。家族が感情を口に出すのを待たず、代わりに決める重さには、こちらから言葉をかけます。

§7 方針と要約（S：Strategy and summary）

Strategy and summary は、相手の準備ができていることを確かめてから今後の方針を一緒に立て、話した内容を要約して面談を閉じる段階です。先の見通しがはっきりしている人ほど、不安と不確かさが少なくなります [Baile Oncologist2000]。

7-1. 方針の話に入ってよいかを確かめる

方針の話の前に、今その話をしてよいかを尋ねます。選択肢があるときに示すことは、相手の希望を大切にしているという姿勢を伝えます [Baile Oncologist2000]。

準備の確認

「これからの治療についてお話ししたいのですが、今お話ししてもよろしいですか。それとも少し時間をおきましょうか」

日を改める

「今日はここまでにして、明日の午後にもう一度お時間をいただけますか」

7-2. 本人の価値観を聴く

ICUでは、出席した家族全員の意向を聴きながらも、話の中心を患者本人の視点に置きます。問いは「ご本人が今ここで話せたら、何とおっしゃるでしょうか」です [Cerceo FamilyMeeting]。

本人の声

「今の状態をご本人がご覧になって、話すことができたら、何とおっしゃると思いますか」

大切にしてきたこと

「ご本人は、どんなことを大切にして暮らしてこられた方ですか。何がお好きでしたか」

以前の話

「こういう状況について、ご家族で話されたことはありましたか」

文化と信念

「ご本人のお考えや習慣で、私たちが知っておいた方がよいことを教えてください」

信仰や信念、宗教上の習慣が治療に関わるときは、SPIRITの6項目で聴き取ります（表7） [Maugans ArchFamMed1996] [Cerceo FamilyMeeting]。日本では信仰を持たないと答える人も多いので、「信仰」だけでなく、大切にしてきた考えや習慣、最期の迎え方への希望として聞きます。

表7｜SPIRIT：信念と価値観の聴き取り

項目	聞くこと
Spiritual belief system	信仰や信念の体系を持っているか
Personal spirituality	その信念を、本人がどう受け止め、実践してきたか
Integration with a spiritual community	信仰の共同体や支えになる仲間とのつながり
Ritualized practices and restrictions	守ってきた儀式や、食事・輸血・処置などの制約
Implications for medical care	それらが今の治療にどう関わるか
Terminal-events planning	最期の迎え方、立ち会い、亡くなった後のことへの希望

7-3. 推奨を示し、期間を区切る

人工呼吸を続けるかなど個別の治療の話は、全体の目標がはっきりしてから行います。目標が決まったら、それに沿った明確な推奨を医師から示します [Cerceo FamilyMeeting]。

見通しが不確かなときは、期間と評価の基準を決めて治療を試みる時間制限つき治療トライアル（time-limited trial）を提案します [Quill JAMA2011]。進行した疾患を持つICU患者209例の質改善研究では、医師がこれを家族面談の既定の進め方として使うように訓練した後、正式な家族面談の実施は60.2%から95.8%に、治療の利益と危険の話し合いは34.9%から94.9%に、本人の価値観と希望の聴き取りは46.5%から98.3%に、改善の目安の共有は20.9%から88.1%に増えました。ICU在室日数の中央値は8.7日から7.4日に短くなり、院内死亡は変わりませんでした [Chang JAMAInternMed2021]。前後比較の研究なので、時期の影響は否定できません。

目標の確認

「お話をうかがうと、ご本人は自分のことは自分でできる生活を大事にされていて、それが難しいなら、機械につながれたままになるのは望まれなかった、ということでしょうか」

推奨

「今うかがったご本人のお考えを踏まえて、私たちからは〇〇をおすすめします」

期間を区切る

「まず1週間、今の治療を続けてみて、〇〇がよくなるかどうかで、もう一度一緒に考えさせてください」

推奨を示すこと、代理判断の考え方、生命維持治療の差し控えと終了の手続きは、ICUの臨床倫理と終末期の意思決定で詳しく扱います。

7-4. 要約して閉じる

面談の最後に、話した内容を短く要約し、伝えたかったことが伝わったかを確かめ、次の予定を決めます（表8）[Cerceo FamilyMeeting]。

表8｜面談の閉じ方

すること	言い回しの例・中身
要約する	今日話したこと、決まったこと、まだ決まっていないことを短くまとめる
評価の目安を共有する	何が起きたら「よくなっている」「悪くなっている」と判断するかを伝える
伝わったかを確かめる	「今日のお話を、来られなかったご家族に伝えるとしたら、どのように伝えますか」（teach-back）
質問を受ける	「帰ってから、聞きたいことが出てくると思います。いつでも聞いてください」
感謝を伝える	「難しいお話に一緒に向き合ってくださって、ありがとうございます」
次の予定を決める	次の面談の日時と、それまでの連絡の方法を決める
記録する	出席者、伝えた内容、家族の理解と反応、決まったことをカルテに残す

§8 ICUの家族面談への拡張

ICUの家族面談は、複数の医療者と複数の家族が向き合う面談で、患者本人は話せないことがほとんどです。SPIKESは医師1人と患者1人の面談を想定して作られているので、ICUでは型を組み替え、面談の姿勢を表す型と組み合わせて使います [Cerceo FamilyMeeting] [Curtis Chest2008]。

8-1. 3つの型

原著のSPIKES、ICUの家族面談向けに組み替えた Modified SPIKES、面談の姿勢を5つにまとめた VALUE の3つを比べます（画面ではタブで切り替えます） [Baile Oncologist2000] [Cerceo FamilyMeeting] [Lautrette NEJM2007]。

SPIKES（原著・6段階）

表9｜SPIKES：原著の6段階

段階	すること	この資料
S：Setting up	伝える内容を準備し、座って話せる場を整える	§2
P：Perception	今の理解を開かれた質問で聞く	§3
I：Invitation	どこまで知りたいかを聞く	§4
K：Knowledge	前置きをして、わかる言葉で小分けに伝える	§5
E：Emotions	感情に共感的な言葉で応える	§6
S：Strategy and summary	準備を確かめて方針を立て、要約する	§7

がん告知のために作られた、医師1人と患者1人の面談の型です [Baile Oncologist2000]。

Modified SPIKES（ICUの家族面談）

表10｜Modified SPIKES：原著との違い

段階	原著からの変更点
S：Set up the situation	カルテを確かめ、関係職種と家族を1室に集め、進行役を1人決め、チームで面談の目標をそろえる
S：Starting	開始を独立させた。出席者全員の紹介、面談の目的、時間の枠を示す
P・I	家族全員の認識をそろえ、情報の量の希望を聞く
K	伝える中身を「病状と治療」「予後」の2点に絞る。許可を取る、話しすぎない、不確かさを認める
E	NURSEで応える。願いには願いの言葉で応え、言い争わない
S：Strategy	本人の視点を中心に、価値観・文化・信念（SPIRIT）を聴く
S：Specific decisions	追加した段階。全体の目標が決まってから個別の治療を決め、推奨と治療トライアルを示す
S：Summary	独立させた段階。要約、評価の目安、teach-back、感謝、次回の予定、カルテへの記録

多職種の家族面談を想定して、準備と開始、方針・個別の決定・要約を分けています [Cerceo FamilyMeeting]。

VALUE（面談の姿勢）

表11｜VALUE：家族面談の5つの姿勢

頭文字	すること
Value	家族の話を大切にし、価値あるものとして受け止める
Acknowledge	家族の感情を認める
Listen	聴く。医療者が話しすぎない
Understand	患者を1人の人として理解するために、どんな人だったかを尋ねる
Elicit	家族の質問を引き出す

段階の型ではなく、面談のどの段階でも保つ姿勢です。死に向かう患者の家族への面談をVALUEに沿って行った試験（§8-2）で使われ、SCCMのガイドラインも家族面談への導入を提案しています [Lautrette NEJM2007] [Hwang CCM2025]。

8-2. 家族面談と家族支援の試験

面談を工夫すると、家族が受け取るコミュニケーションの質は上がります。一方、家族の長期の不安・抑うつ・PTSD症状を減らせた試験は限られます（表12）。表の数字はすべて「介入群／対照群」の順です。不安・抑うつ（HADS）、PTSD症状（IES-R）、遷延性悲嘆は低いほど、コミュニケーションの質は高いほど良い値です。

表12｜ICUの家族面談・家族支援の主な試験

試験	対象・介入	主な結果（介入群／対照群）
Lautrette（NEJM 2007）	フランス22 ICU、死に向かう患者126例の家族。VALUEに沿った積極的な終末期面談＋死別のパンフレット	面談 30分／20分、家族が話した時間 14分／5分。90日後に症状がある家族：PTSD関連 45%／69%、不安 45%／67%、抑うつ 29%／56% [Lautrette NEJM2007]
Curtis（AJRCCM 2016）	2病院、168例。コミュニケーション・ファシリテーター	6か月の抑うつ症状は減ったが、3か月の症状、6か月の不安・PTSDは差なし。死亡例のICU在室 7.7日／28.5日 [Curtis AJRCCM2016]
Carson（JAMA 2016）	4 ICU、慢性重症患者の家族365人。緩和ケア医が行う2回以上の面談	3か月の不安・抑うつは差なし（HADS 12.2点／11.4点）。PTSD症状は介入群で多かった（IES-R 25.9点／21.3点） [Carson JAMA2016]

試験	対象・介入	主な結果（介入群／対照群）
PARTNER（NEJM 2018）	5 ICU、1420例。多職種チームによる多要素の家族支援	6か月の不安・抑うつは差なし（HADS 11.7点／12.0点）。コミュニケーションの質 69.1点／62.7点、ICU在室 6.7日／7.4日 [White NEJM2018]
Kentish-Barnes（Lancet 2022）	フランス34 ICU、遺族875人。死の前・最中・後の3段階の面談	6か月の遷延性悲嘆 15%／21%。絶対差は小さい [Kentish-Barnes Lancet2022]
Caregiver Pathway（ICM 2025）	ノルウェー単施設、家族196人。VALUEの訓練を受けた看護師による4段階の伴走	6か月のPTSD症状 IES-R 25.8点／30.9点。効果は患者が生存した家族に限られた [Watland ICM2025]
FICUS（ICM 2026）	スイス16 ICU、885家族。家族ナースによる構造化した家族ケア	家族機能・不安・抑うつ・PTSDなど8項目すべて差なし [Riguzzi ICM2026]
Creutzfeldt（CCM 2026）	米国3病院、449例。退院後3か月まで伴走するファシリテーター	6か月間の抑うつ症状（HADS-うつ）の群間差 −0.07点で差なし。医療チームとの関係はわずかに改善 [Creutzfeldt CCM2026]

看護師が主導する家族コミュニケーション介入14研究（家族2885人）の系統的レビューでも、コミュニケーションの質（標準化平均差 0.26）と在院日数（−3.87日）は改善しましたが、不安・抑うつ・PTSD・満足度・ICU在室・死亡は変わりませんでした [Li CCM2026]。

8-3. 試験から言えること

家族の長期の心理症状を、ICUの中の介入だけで動かすのは難しいことが、20年の試験でわかってきました [Aslakson CCM2026]。

- はっきり効いた最初の試験（Lautrette）は、面会時間が短く、家族がケアや意思決定にほとんど参加していなかった時代の試験です。今のICUには当時ほどの伸びしろがないかもしれません [Aslakson CCM2026]
- 面談の中身が変わると、家族が受け取るコミュニケーションの質、家族が話す時間、死亡例の在室日数は変わります [Lautrette NEJM2007] [White NEJM2018] [Li CCM2026]
- 緩和ケア医の面談を全例に一律に入れても、不安・抑うつは減らず、PTSD症状は増えました [Carson JAMA2016]。面談の回数を増やすことと、面談の質を上げることは別です
- 長期の心理症状だけで評価すると、面談のその場で家族の苦痛が和らいだという効果が見えなくなる、という指摘があります [Ashana ICM2026]

レジデントが日々の面談で変えられるのは、医療者が話しすぎない、家族の話を聴く、感情に応える、本人の価値観を聴く、という面談の中身です。これは表12の試験の多くに共通する要素で、ガイドラインも支持しています（§8-4）。

8-4. ガイドライン

SCCMとESICMのガイドラインは、どちらも構造化した家族面談と、医療者へのコミュニケーション訓練を勧めています（表13）。推奨の確実性はどれも低いです。

表13｜家族とのコミュニケーションに関するガイドラインの推奨

ガイドライン	推奨
SCCM 成人ICUの家族中心ケア（2024）	多職種の家族面談の標準化とVALUEの使用、医療者へのコミュニケーション訓練、専攻医・フェローへの模擬患者を使った高忠実度シミュレーション訓練（いずれも条件付き・確実性は低い） [Hwang CCM2025]
ESICM ICUの終末期・緩和ケア（2024）	ICUスタッフへのコミュニケーション訓練と、家族向けの印刷した説明資料。構造化した家族面談と、文化に配慮した介入 [Kesecioglu ICM2024]
ESICM 人間中心のパートナーシップ合意（2026）	柔軟な面会、家族の参加、構造化した家族との対話を中核とする [Latour ICM2026]

8-5. 正式な面談の外の短い対話

正式な家族面談だけが対話の場ではありません。議題を決めない毎日の短い声かけで、医療者が話すより聴くことを重ねると、家族が本当に困っていること（宿泊費や仕事の休みなど）が初めて出てきます [Ashana ICM2026]。

家族は、医療者以外からも多くの情報（ときには誤った情報）を得ています。医師の役割は、唯一の情報源であることから、情報の中を一緒に進む案内役へと移っています [Ashana ICM2026]。毎日の短い対話で信頼ができていると、悪い知らせを伝える面談の土台になります。

§9 難しい場面

この章では、怒りや対立があるとき、家族が回復を強く願っているとき、脳死を伝えるときの3つの場面を扱います。どの場面でも、SPIKESの段階は同じで、Eに使う時間が長くなります。

9-1. 怒りと対立

ICUの対立は、何をすべきかの対立（課題）、誰がどう決めるかの対立（プロセス）、信頼と敬意が損なわれた対立（関係）の3つの層で起こります。関係の層まで進むと解決は格段に難しくなるので、課題とプロセスの段階で手を打ちます [Jabaley CritCare2026]。

予防に効くのは、個人の話術よりも仕組みです。構造化した回診、役割の明確化、面談前のチームのすり合わせ、時間制限つき治療トライアルなどの既定の進め方が挙げられています [Jabaley CritCare2026]。「困った家族」という呼び方は、家族の立場（何を求めているか）だけを見て、その奥の関心（なぜ求めているか）を探っていないことの表れです [Tuinman ICM2026]。面談では、交渉学の技法が使えます（表14）。

表14｜家族面談で使える交渉の技法

技法	すること	言い回しの例
聴くことから始める	相手の見方を先に十分に聴き、こちらの理解を言葉にして返す	「まず、ご家族がこの数日をどう見てこられたか、聞かせてください」
懸念を先に言葉にする	相手が抱いていそうな不満や疑いを、こちらから先に口にする	「説明が人によって違う、と感じていらっしゃるかもしれません」
ラベリング	相手の感情や考えを「〜のように見えます」と名づける	「私たちが早くあきらめようとしている、と心配されているように見えます」
立場から関心へ	「全部やってほしい」という立場の奥にある関心を探る	「「できることは全部」とおっしゃるとき、いちばん避けたいのはどんなことですか」
開かれた問い	二者択一を避け、「どうすれば」「何が」で問う	「どうすれば、ご本人らしい時間にできると思われますか」
小さな本物の選択	家族が実際に選べることを示す	「次のお話は、ご家族がそろう週末と平日の夕方、どちらがよいですか」
要約と次の一歩	合意したことと、次に何をするかで閉じる	「今日は〇〇まで一致しました。〇〇については、明日もう一度話しましょう」

これらは台本ではなく、面談に臨む構えと道具です [Tuinman ICM2026]。話し合いが行き詰まり、価値観の対立が続くときは倫理コンサルテーション、関係の断裂には調停など、公式の支援を使います [Jabaley CritCare2026]。

9-2. 回復を強く願う家族

家族が「奇跡を信じています」「絶対によくなってほしい」と話すとき、それを訂正しようとせず、願いの言葉（wish statement）で受け止めます [Quill AnnInternMed2001] [Cerceo FamilyMeeting]。

「私も、そうであればと願っています」という言葉は、家族の願いを否定せずに受け止め、同時に医学的な事実は変えずに残せます [Quill AnnInternMed2001]。願いを受け止めたうえで、最善を望みつつ最悪に備える視点を示します（§5-3） [Back AnnInternMed2003]。家族の楽観の背景には、希望を保つことが患者のためになるという考えや信仰があることが多く（§3-3）、言い争っても埋まりません [White JAMA2016]。

願いの言葉

「よくなってほしいというお気持ち、よくわかります。私も、よくなるとお約束できればと思います」

希望と備え

「よくなることを願って、できる治療を続けています。ただ、もしうまくいかなかったときのことを、少し考えてみたことはありますか」

避ける

~~「奇跡は起きません。現実を受け入れてください」~~

避ける

~~「医学的にはもう無理です」~~

9-3. 脳死を伝える

脳死の説明では、単純で明確な言葉を使い、誤った希望を与える言葉を避け、複数回会い、判定に立ち会う機会を示します [Wu JAMA2026]。

家族にとって脳死がわかりにくいのは、脊髄反射による体の動き、脈があること、人工呼吸で胸が上下すること、皮膚が温かいことのためです。あいまいな言葉は混乱をさらに深めます [Wu JAMA2026]。

避ける

~~「生命維持装置で生きています」~~

言い換え

「人工呼吸器や薬は、体の臓器を支えるために使っています」

避ける

~~「昏睡状態です」~~

言い換え

「脳がすべての働きを失い、回復することのない損傷を受けています」

患者のことは過去形で語ります。判定は「生きている徴候がないかを確かめる検査」と位置づけ、無呼吸テストを含む判定への立ち会いを提案できます。立ち会いの有無を比べた小規模なランダム化試験では、脳死の理解度が満点だった家族は立ち会った群66%、立ち会わなかった群20%で、心理的な影響に差はありませんでした [Wu JAMA2026]。判定する医師と臓器提供の担当者の役割は分けます。この提言は米国の制度を前提にしているので、判定の手続きは日本の法律と施設の規程に従い、言葉の使い方を取り入れます。

§ 10 型の限界と身につけ方

SPIKESは面談の台本ではなく、準備と振り返りのための枠組みです。定型の言葉を機械的に唱えると、かえって空々しく響きます。この資料の言い回しの例は、自分の言葉に直して使います。

10-1. エビデンスの水準

原著には患者の転帰のデータがありません。示されたのは、学会参加者の94.8%が「理にかなっている」、95.4%が「臨床で使える」と答えたという自己申告の調査です [Baile Oncologist2000]。

SPIKESを使った教育の研究37編の系統的レビューでは、教育によって学習者の満足度・知識・面談の技能は改善しましたが、患者の転帰や医療システムへの影響を調べた研究は1つもありませんでした [Mahendiran AmJHospPalliatCare2023]。NURSEとSPIRITは別の著者が別の文脈で作った型で、ICUの家族面談で効果を確かめたものではありません [Back CACancerJClin2005] [Maugans ArchFamMed1996]。

10-2. 練習すると変わる

悪い知らせの伝え方は、模擬患者を使った練習で、観察できる行動として変わります [Back ArchInternMed2007] [Fujimori JCO2014]。

- 腫瘍内科フェロー115人の4日間の合宿型研修（Oncotalk）では、模擬患者との面談で、悪い知らせの技能が平均5.4個、緩和ケアへの移行を話す技能が平均4.4個増えました。悪い知らせを伝える際に「がん」という言葉を使えたフェローは、研修前の16%か

ら研修後の54%になりました [Back ArchInternMed2007]

- 日本のSHAREに基づく2日間の研修のランダム化試験（腫瘍内科医30人）では、研修を受けた医師で情緒的な支え・場の設定・情報の伝え方の技能が上がり、その医師の面談を受けた患者の抑うつが少なくなりました。患者の満足度は変わりませんでした [Fujimori JCO2014]
- SCCMのガイドラインは、専攻医・フェローへの模擬患者を使った訓練を提案しています [Hwang CCM2025]

練習の後は、実際の面談を振り返ります。上級医の面談に同席したら、図2の6段階のどこで何をしていたか、どこで家族の感情があふれ、どう応えたかを、面談の後に短く話し合います。

主要文献

- Baile WF, Buckman R, Lenzi R, Glober G, Beale EA, Kudelka AP. SPIKES—A six-step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. Oncologist. 2000;5(4):302-311. doi:10.1634/theoncologist.5-4-302
- Cerceo E. A Guide for Conducting a Family Meeting: Modified "SPIKES" (original by Baile & Buckman).
- Back AL, Arnold RM, Baile WF, Tulsky JA, Fryer-Edwards K. Approaching difficult communication tasks in oncology. CA Cancer J Clin. 2005;55(3):164-177. doi:10.3322/canjclin.55.3.164
- Maugans TA. The SPIRITual history. Arch Fam Med. 1996;5(1):11-16. doi:10.1001/archfami.5.1.11
- 渡辺亨. SPIKESを使った正しい情報提供術を学ぶ. ナースのためのコミュニケーションスキルシリーズ①.
- Fujimori M, Akechi T, Morita T, et al. Preferences of cancer patients regarding the disclosure of bad news. Psychooncology. 2007;16(6):573-581. doi:10.1002/pon.1093
- Fujimori M, Shirai Y, Asai M, Kubota K, Katsumata N, Uchitomi Y. Effect of communication skills training program for oncologists based on patient preferences for communication when receiving bad news: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2014;32(20):2166-2172. doi:10.1200/JCO.2013.51.2756
- Rusinova K, Rusina R, Pantilat SZ. Understanding the neuroscience of communicating serious news. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08578-0
- Azoulay E, Chevret S, Leleu G, et al. Half the families of intensive care unit patients experience inadequate communication with physicians. Crit Care Med. 2000;28(8):3044-3049. doi:10.1097/00003246-200008000-00061
- McDonagh JR, Elliott TB, Engelberg RA, et al. Family satisfaction with family conferences about end-of-life care in the intensive care unit: increased proportion of family speech is associated with increased satisfaction. Crit Care Med. 2004;32(7):1484-1488. doi:10.1097/01.ccm.0000127262.16690.65
- White DB, Ernecoff N, Buddadhumaruk P, et al. Prevalence of and factors related to discordance about prognosis between physicians and surrogate decision makers of critically ill patients. JAMA. 2016;315(19):2086-2094. doi:10.1001/jama.2016.5351
- Selph RB, Shiang J, Engelberg R, Curtis JR, White DB. Empathy and life support decisions in intensive care units. J Gen Intern Med. 2008;23(9):1311-1317. doi:10.1007/s11606-008-0643-8
- Back AL, Arnold RM, Quill TE. Hope for the best, and prepare for the worst. Ann Intern Med. 2003;138(5):439-443. doi:10.7326/0003-4819-138-5-200303040-00028
- Quill TE, Arnold RM, Platt F. "I wish things were different": expressing wishes in response to loss, futility, and unrealistic hopes. Ann Intern Med. 2001;135(7):551-555. doi:10.7326/0003-4819-135-7-200110020-00022
- Kruser JM, Taylor LJ, Campbell TC, et al. "Best Case/Worst Case": training surgeons to use a novel communication tool for high-risk acute surgical problems. J Pain Symptom Manage. 2017;53(4):711-719.e5. doi:10.1016/j.jpainsymman.2016.11.014
- Quill TE, Holloway R. Time-limited trials near the end of life. JAMA. 2011;306(13):1483-1484. doi:10.1001/jama.2011.1413
- Chang DW, Neville TH, Parrish J, et al. Evaluation of time-limited trials among critically ill patients with advanced medical illnesses and reduction of nonbeneficial ICU treatments. JAMA Intern Med. 2021;181(6):786-794.

doi:10.1001/jamainternmed.2021.1000

- Curtis JR, White DB. Practical guidance for evidence-based ICU family conferences. Chest. 2008;134(4):835-843. doi:10.1378/chest.08-0235
- Lautrette A, Darmon M, Megarbane B, et al. A communication strategy and brochure for relatives of patients dying in the ICU. N Engl J Med. 2007;356(5):469-478. doi:10.1056/NEJMoa063446
- Curtis JR, Treece PD, Nielsen EL, et al. Randomized trial of communication facilitators to reduce family distress and intensity of end-of-life care. Am J Respir Crit Care Med. 2016;193(2):154-162. doi:10.1164/rccm.201505-0900OC
- Carson SS, Cox CE, Wallenstein S, et al. Effect of palliative care-led meetings for families of patients with chronic critical illness: a randomized clinical trial. JAMA. 2016;316(1):51-62. doi:10.1001/jama.2016.8474
- White DB, Angus DC, Shields AM, et al; PARTNER Investigators. A randomized trial of a family-support intervention in intensive care units. N Engl J Med. 2018;378(25):2365-2375. doi:10.1056/NEJMoa1802637
- Kentish-Barnes N, Chevret S, Valade S, et al. A three-step support strategy for relatives of patients dying in the intensive care unit: a cluster randomised trial. Lancet. 2022;399(10325):656-664. doi:10.1016/S0140-6736(21)02176-0
- Watland S, Solberg Nes L, Ekeberg Ø, et al. Effects of The Caregiver Pathway intervention on symptoms of post-intensive care syndrome among family caregivers to critically ill patients: long-term results from a randomized controlled trial. Intensive Care Med. 2025;51(11):2042-2053. doi:10.1007/s00134-025-08139-x
- Riguzzi M, Jeitziner MM, Rufer M, et al; FICUS study group. The FICUS cluster randomized controlled trial of a family support intervention in adult intensive care units: mental health and family functioning outcomes. Intensive Care Med. 2026;52:637-650. doi:10.1007/s00134-026-08425-2
- Creutzfeldt CJ, Brumback LC, Im J, et al. Facilitating communication for family members of critically ill patients during and following a hospital stay: a randomized controlled trial. Crit Care Med. 2026;54. doi:10.1097/CCM.0000000000007268
- Li Z, Lu F, Abshire Saylor M, et al. Characteristics and effectiveness of nurse-led family communication interventions in the ICU: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2026;54(2):301-311. doi:10.1097/CCM.0000000000006952
- Aslakson RA, Cox CE, White DB. Family support interventions in the ICU: reckoning with the past and planning for the future. Crit Care Med. 2026;54. doi:10.1097/CCM.0000000000007322
- Ashana DC, Cox CE. ICU communication: "state of the art". Intensive Care Med. 2026;52(6):1333-1335. doi:10.1007/s00134-026-08364-y
- Hwang DY, Oczkowski SJW, Lewis K, et al. Society of Critical Care Medicine guidelines on family-centered care for adult ICUs: 2024. Crit Care Med. 2025;53(2):e465-e482. doi:10.1097/CCM.0000000000006549
- Kesecioglu J, Rusinova K, Alampi D, et al. European Society of Intensive Care Medicine guidelines on end of life and palliative care in the intensive care unit. Intensive Care Med. 2024;50:1740-1766. doi:10.1007/s00134-024-07579-1
- Latour JM, Rodriguez-Ruiz E, Arabi YM, et al. European Society of Intensive Care Medicine consensus statement on human-centred partnership in the intensive care unit. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08626-9
- Jabaley CS, Brummell Z, Benoit DD, Kentish-Barnes N, Metaxa V. Conflict in intensive care units: a conceptual framework for patient, family, team, and inter-service disagreement. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06248-7
- Tuinman PR, Metaxa V. ICU toolbox: negotiation skills for family conversations in the ICU. Intensive Care Med. 2026;52:1098-1100. doi:10.1007/s00134-025-08287-0
- Wu A, Hirsch KG, Magnus D. Communicating with families about brain death. JAMA. 2026. doi:10.1001/jama.2026.9970
- Back AL, Arnold RM, Baile WF, et al. Efficacy of communication skills training for giving bad news and discussing transitions to palliative care. Arch Intern Med. 2007;167(5):453-460. doi:10.1001/archinte.167.5.453
- Mahendiran M, Yeung H, Rossi S, Khosravani H, Perri GA. Evaluating the effectiveness of the SPIKES model to break bad news: a systematic review. Am J Hosp Palliat Care. 2023;40(11):1231-1260. doi:10.1177/10499091221146296